



Un curso del COP forma a profesionales de las OAVD, SALUD MENTAL ESPAÑA presenta el manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental y dos estudios analizan la rehabilitación cognitiva tras un ictus y un traumatismo craneoencefálico leve: claves del 6 de octubre de 2026

MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Consejo General de la Psicología de España ha acogido un curso, organizado junto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para profesionales que atienden a víctimas del delito en las OAVD, con una jornada dedicada al cuidado del propio personal. SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado el manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2026, que reclama voz en las políticas públicas, inclusión comunitaria y espacios libres de ciberacoso. Un ensayo aleatorizado con 20 personas halla mejor cognición global con rehabilitación multicontextual tras un ictus crónico, y una cohorte retrospectiva de 185 pacientes asocia la rehabilitación cognitiva temprana con mejores resultados a los 12 meses tras un traumatismo craneoencefálico leve.

Noticias nacionales

El COP acoge un curso para profesionales de las OAVD con jornadas sobre el autocuidado del personal y los delitos de odio

El Consejo General de la Psicología de España (COP) ha acogido en su sede, los días 1 y 2 de octubre de 2026, una nueva edición del curso «Atención e Intervención Psicológica con Víctimas del Delito desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito», según informa Infocop. La formación se ofreció en formato presencial y online, está organizada por el COP en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la coordinan Fernando Chacón Fuertes y Mario García Martínez. Se dirige a profesionales de la psicología que trabajan en la atención a víctimas del delito. El programa se articuló en dos jornadas. La primera se centró en el bienestar psicológico y la resiliencia del personal que atiende a víctimas, con talleres dirigidos por Olga Barroso Braojos bajo el lema «Ser cuidados para cuidar». La segunda abordó los delitos de odio y la discriminación, con presentaciones sobre el plan de actuación de la Guardia Civil y un análisis desde la perspectiva de la homofobia interiorizada, la discriminación y los delitos de odio, a cargo de Gabriel J. Martín. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) constituyen el marco institucional para la asistencia especializada a las personas que han sufrido delitos. La información procede de la crónica que Infocop publicó el 5 de octubre de 2026.

Fuente: Infocop

SALUD MENTAL ESPAÑA presenta el manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2026, que pide dar voz a las personas con experiencia en salud mental y espacios libres de ciberacoso

SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado el Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2026, firmado por el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y por la Red Estatal de Mujeres de la entidad. El texto, difundido el 5 de octubre de 2026, plantea que el futuro sea un terreno seguro para la juventud, y su lectura está prevista para el 9 de octubre de 2026 a las 10:30 horas. El manifiesto recoge varias reivindicaciones. Pide dar voz y escuchar a las personas con

experiencia en salud mental en el diseño de las políticas públicas; reclama el derecho a ser incluidas en la comunidad y a recibir apoyo comunitario desde edades tempranas; solicita abordar la precarización del contexto laboral y de la vivienda; exige espacios libres de violencia, con una mención específica al ciberacoso; y defiende que las personas puedan recuperar sus proyectos, sus relaciones y su autonomía sin que un diagnóstico sea una barrera para una vida mejor. El documento no incluye estadísticas ni cifras y menciona la financiación de la Fundación ONCE y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata de un posicionamiento de la entidad y de un conjunto de reclamaciones, no de una medida aprobada ni de una norma.

Fuente: SALUD MENTAL ESPAÑA

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un ensayo aleatorizado con 20 personas halla mejor cognición global con rehabilitación multicontextual tras un ictus crónico, sin diferencias en independencia funcional

Un ensayo controlado aleatorizado publicado el 28 de marzo de 2026 en Discover Psychology evalúa la rehabilitación cognitiva con un enfoque multicontextual en personas con ictus crónico, de entre 6 y 24 meses desde el episodio. Firman el trabajo Özden Erkan Oğul, Esma Özkan, Gonca Bumin y Yakup Krespi. Participaron 20 personas, repartidas a partes iguales en dos grupos. El grupo de intervención recibió rehabilitación cognitiva multicontextual combinada con enfoques remediales y fisioterapia estándar, con tres sesiones semanales de una hora durante ocho semanas; el grupo control recibió solo fisioterapia estándar con la misma frecuencia. Tras la intervención hubo diferencias significativas entre grupos en cognición global medida con el MoCA ($p = 0,006$; $\eta^2p = 0,371$) y en la puntuación total de la LOTCA ($p < 0,001$), con mejoras en percepción visual ($p = 0,002$), organización visomotora ($p < 0,001$) y atención ($p = 0,031$). No fueron significativas la percepción espacial ($p = 0,236$) ni las habilidades de pensamiento ($p = 0,121$). En desempeño ocupacional (COPM) mejoraron el rendimiento ($p = 0,031$) y la

satisfacción ($p = 0,012$), mientras que la independencia funcional (FIM; $p = 0,086$) y la participación social (CHART-SF; $p = 0,428$) no mostraron diferencias significativas. Los autores hablan de evidencia preliminar y señalan como limitaciones el tamaño muestral reducido (10 personas por grupo), la restricción a la fase crónica y que los evaluadores no estaban cegados a la asignación de grupos.

Fuente: Discover Psychology (Springer)

NEUROCIENCIA · INTERNACIONAL

Un estudio de cohorte con 185 pacientes asocia la rehabilitación cognitiva temprana con mejor recuperación a los 12 meses tras un traumatismo craneoencefálico leve

Un estudio de cohorte retrospectivo de un único centro, publicado el 13 de julio de 2026 en *Frontiers in Human Neuroscience*, analiza la relación entre la rehabilitación cognitiva temprana y la recuperación a largo plazo tras un traumatismo craneoencefálico leve. Firman Yi Ren, Huiying Wu, Yumei Lu, Qi Zeng y Qian Su. Incluye a 185 pacientes con un seguimiento mínimo de 12 meses: 91 recibieron rehabilitación cognitiva temprana y 94 no. A los 12 meses, el grupo con rehabilitación temprana mejoró más en el MoCA (7,03 frente a 3,01 puntos; $p < 0,001$) y una mayor proporción alcanzó una puntuación igual o superior a 26 (34,1 % frente a 7,4 %). También obtuvo mayor puntuación en actividades de la vida diaria ($90,56 \pm 7,74$ frente a $74,28 \pm 9,80$; $p < 0,001$) y más resultados funcionales favorables en la GOS-E (61,5 % frente a 28,7 %; $p < 0,001$). La mejora en el MoCA fue mayor con más sesiones: 5,39 puntos con 4 o menos, 6,81 con entre 5 y 7, y 9,30 con 8 o más. Los marcadores séricos NfL, GFAP e IL-6 fueron más bajos en el grupo con rehabilitación temprana a los 6 y a los 12 meses, un resultado de carácter exploratorio. Los autores señalan como limitaciones el diseño retrospectivo, con posible sesgo de selección, el registro incompleto de factores de confusión como el nivel socioeconómico y la adherencia, la neuroimagen limitada a TC sin contraste y un grupo control heterogéneo en el momento de inicio de la rehabilitación.

Fuente: *Frontiers in Human Neuroscience*

Publicaciones científicas recientes

Oğul, Ö. E., Özkan, E., Bumin, G., & Krespi, Y. (2026). The effect of cognitive rehabilitation with a multicontextual treatment approach in stroke: a randomized controlled trial. *Discover Psychology*, 6, Article 130. <https://doi.org/10.1007/s44202-026-00668-w>

DOI: [10.1007/s44202-026-00668-w](https://doi.org/10.1007/s44202-026-00668-w)

Hallazgo: Con 20 personas con ictus crónico repartidas en dos grupos de 10 y un programa de ocho semanas, el grupo que recibió rehabilitación cognitiva multicontextual además de fisioterapia estándar mostró diferencias significativas frente al control en el MoCA ($p = 0,006$) y en la LOTCA total ($p < 0,001$), así como en rendimiento y satisfacción ocupacional del COPM. No se observaron diferencias significativas en independencia funcional (FIM; $p = 0,086$) ni en participación social (CHART-SF; $p = 0,428$).

Implicación clínica: Los resultados sugieren que combinar estrategias de transferencia con enfoques remediales puede mejorar el funcionamiento cognitivo y el desempeño ocupacional en la fase crónica del ictus, aunque los propios autores lo presentan como evidencia preliminar. La muestra pequeña y la ausencia de cegamiento de los evaluadores invitan a interpretar las cifras con cautela.

Ren, Y., Wu, H., Lu, Y., Zeng, Q., & Su, Q. (2026). Association between early cognitive rehabilitation and long-term cognitive recovery in patients with mild traumatic brain injury: a retrospective cohort study. *Frontiers in Human Neuroscience*. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2026.1846518>

DOI: [10.3389/fnhum.2026.1846518](https://doi.org/10.3389/fnhum.2026.1846518)

Hallazgo: En una cohorte retrospectiva de 185 pacientes con traumatismo craneoencefálico leve (91 con rehabilitación cognitiva temprana y 94 sin ella), el grupo con rehabilitación temprana mejoró 7,03 puntos en el MoCA a los 12 meses frente a 3,01 del otro grupo ($p < 0,001$), y un 61,5 % tuvo un resultado funcional favorable en la GOS-E frente al 28,7 % ($p < 0,001$). La mejora fue mayor con más sesiones de rehabilitación.

Implicación clínica: Para la práctica clínica, los resultados pueden orientar la reflexión sobre el momento de inicio y la frecuencia de la rehabilitación cognitiva, pero al ser un diseño retrospectivo muestran una asociación y no

permiten establecer causalidad. Los marcadores séricos se describen como exploratorios.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Cribado cognitivo breve para el seguimiento de la rehabilitación:** Los dos estudios usaron el Montreal Cognitive Assessment (MoCA) como medida de cognición global antes y después de la rehabilitación. Es una prueba de cribado y no sustituye a una evaluación neuropsicológica completa, por lo que suele combinarse con medidas más específicas.
- **Medidas combinadas de desempeño ocupacional, independencia y participación:** El ensayo sobre ictus complementó la evaluación cognitiva con una medida de desempeño ocupacional centrada en la persona (COPM), una escala de independencia funcional (FIM) y un cuestionario de participación (CHART-SF), lo que permitió comprobar que los cambios cognitivos no se acompañaron de diferencias significativas en independencia ni participación.

Prioridades del día

Cuidar a quienes atienden a víctimas

Puede ser útil explorar espacios de autocuidado y supervisión para los equipos que atienden a víctimas del delito, en línea con el enfoque de «Ser cuidados para cuidar» que se trabajó en la primera jornada del curso del COP.

Combinar medidas cognitivas y funcionales

Puede ser relevante incorporar, junto a una prueba cognitiva global, medidas de independencia y participación, dado que en el ensayo sobre ictus las diferencias cognitivas no se acompañaron de diferencias significativas en esas dos áreas.

Leer con cautela el diseño de cada estudio

Puede ser oportuno distinguir entre un ensayo pequeño que se presenta como evidencia preliminar y una cohorte retrospectiva que muestra asociaciones, y reflejar esa distinción cuando se citen estos resultados en informes o materiales divulgativos.

